Op. Dr. Murat Ayata
Kulak Burun Boğaz
Facharzt für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde und Kopf-Hals-Chirurgie

Privatpraxis Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Türkei
Tel.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

AUFKLÄRUNGS- UND EINWILLIGUNGSBOGEN

Septumplastik

Operation zur Begradigung der Nasenscheidewand (Nasenseptum)

Liebe Patientin, lieber Patient, dieser Bogen soll Ihnen in **einfacher und verständlicher Sprache** erklären, was Sie über den Ihnen empfohlenen Eingriff wissen sollten. Er soll Ihnen keine Angst machen, sondern Ihnen helfen, Ihre Entscheidung **frei und gut informiert** zu treffen.

Bitte lesen Sie diesen Bogen in Ruhe durch. Fragen Sie Ihren Arzt nach allem, was Sie nicht verstehen. Ihr Arzt wird Ihnen außerdem mündlich die Risiken erläutern, die speziell in Ihrer Situation bestehen. Ob Sie Ihre Einwilligung geben oder nicht, ist allein Ihr Recht.

ANGABEN ZU PATIENT/IN UND EINGRIFF

Vor- und Nachname: _____ Geburtsdatum: _____

Reisepass- / Ausweisnummer: _____ Akten- / Protokollnummer: _____

Telefon: _____ Datum der Aufklärung: _____

Geplantes Datum des Eingriffs: _____

Bogen erstmals an Patient/in übermittelt (Datum / E-Mail, WhatsApp, persönlich): _____

Durchführender und aufklärender Arzt: **Op. Dr. Murat Ayata**

Krankenhaus / Einrichtung, in der der Eingriff durchgeführt wird: _____

Gleichzeitig durchzuführende Eingriffe:
- ☐ Verkleinerung der Nasenmuscheln (Radiofrequenz / submukös)
- ☐ Endoskopische Nasennebenhöhlenoperation — FESS (auf separatem Aufklärungsbogen)
- ☐ Keine _____

Nasenschienen / Tamponaden:
- ☐ Silikonschienen ☐ Tamponaden ☐ Nicht erforderlich
- ☐ Entscheidung während der Operation _____

Beschwerden der Patientin / des Patienten (Seite der Behinderung, Schnarchen, Kopfschmerzen usw.): _____

1 Ihre Erkrankung und das Ziel des Eingriffs

Die Wand aus Knorpel und dünnem Knochen, die die Nasenhöhle in eine rechte und eine linke Seite teilt, wird **Septum** (Nasenscheidewand) genannt. Ist das Septum zu einer oder zu beiden Seiten verbogen, spricht man von einer **Septumdeviation**. Sie kann angeboren sein, sich während des Wachstums entwickeln oder nach einem Schlag auf die Nase entstehen.

Eine verkrümmte Nasenscheidewand kann zu behinderter Nasenatmung, Mundatmung, Schnarchen, schlechtem Schlaf, Mundtrockenheit, Nasenbluten und bei manchen Menschen zu wiederkehrenden Nasennebenhöhlenentzündungen oder Kopfschmerzen führen. Da es sich um ein strukturelles Problem handelt, bessert es sich nicht durch Medikamente. Ziel der Septumplastik ist es, die verkrümmten Anteile zu begradigen, damit Sie **frei durch die Nase atmen können**. Diese Operation zielt nicht darauf ab, das äußere Erscheinungsbild der Nase zu verändern.

Privatpraxis Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Türkei
Tel.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

2 Wie wird der Eingriff durchgeführt?

Die Operation wird in der Regel in Vollnarkose im Operationssaal durchgeführt, ausschließlich durch die Nasenlöcher. Im Gesicht entsteht kein sichtbarer Schnitt und keine Narbe.

1. **Schnitt:** Im Naseneingang wird ein kleiner Schnitt in die Schleimhaut (Mukosa) gesetzt, die das Septum bedeckt.
2. **Ablösen der Schleimhaut:** Die Schleimhaut, die das Septum auf beiden Seiten bedeckt, wird behutsam von Knorpel und Knochen gelöst.
3. **Korrektur der Verkrümmung:** Die verbogenen Knorpel- und Knochenanteile werden entfernt, begradigt oder neu positioniert. Die tragenden Strukturen, die die äußere Form der Nase halten (das Knorpelgerüst, das Nasenrücken und Nasenspitze stützt), bleiben erhalten.
4. **Verkleinerung der Nasenmuscheln (falls erforderlich):** Sind die an der Seitenwand der Nase liegenden Strukturen, die Nasenmuscheln, vergrößert, werden sie mit Radiofrequenz oder durch Gewebeentfernung unter der Schleimhaut verkleinert.
5. **Wundverschluss:** Die Schleimhaut wird wieder angelegt und mit selbstauflösenden Fäden fixiert.
6. **Schienen/Tamponaden:** Damit das Septum gerade verheilt und um Blutungen vorzubeugen, werden in der Regel weiche Silikonschienen mit zentralem Atemröhrchen oder Tamponaden in die Nase eingelegt.

Ist auch der vordere und äußere Teil des Septums verkrümmt oder trägt die äußere Nasenform zur Atmungsbehinderung bei, kann die Operation mit einer Rhinoplastik kombiniert werden (Septorhinoplastik), sofern dies gesondert besprochen und darin eingewilligt wurde.

BETÄUBUNG (ANÄSTHESIE)	VORAUSSICHTLICHE DAUER	KRANKENHAUSAUFENTHALT / ENTLASSUNG
Vollnarkose (in ausgewählten Fällen örtliche Betäubung + Sedierung)	Etwa 45–90 Minuten	Entlassung am selben Tag oder eine Nacht im Krankenhaus

3 Erwarteter Nutzen und Erfolgsaussichten

- Freiere Nasenatmung und weniger Mundatmung
- Bessere Schlafqualität und weniger Schnarchen (Schnarchen kann auch andere Ursachen haben)
- Weniger wiederkehrendes Nasenbluten infolge der Verkrümmung und bei manchen Patientinnen und Patienten weniger Nasennebenhöhlenentzündungen
- Besserer Zugang für eine gegebenenfalls notwendige Nasennebenhöhlen- oder andere Nasenoperation

In Fachveröffentlichungen wird berichtet, dass etwa **70–85 von 100** Patientinnen und Patienten nach der Operation eine deutliche Besserung der Nasenatmungsbehinderung angeben. Hat die Behinderung auch andere Ursachen, etwa eine Allergie, eine Schleimhautschwellung, ein Einfallen der Nasenflügel oder eine Erkrankung der Nasennebenhöhlen, müssen diese gegebenenfalls gesondert behandelt werden. Selten kann sich das Septum im Laufe der Zeit allmählich wieder leicht verbiegen.

4 Andere Behandlungsmöglichkeiten

- **Keine Operation / abwartendes Beobachten:** Sind Ihre Beschwerden gering, können sie einfach beobachtet werden.
- **Medikamentöse Behandlung:** Kortisonhaltige Nasensprays, Nasenspülungen und Allergiemedikamente können die Beschwerden durch Abschwellen der Schleimhaut lindern, korrigieren aber keine strukturelle Verkrümmung von Knochen und Knorpel.
- **Nasenpflaster / Nasendilatatoren:** Können vorübergehend Erleichterung verschaffen.
- **Abschwellende Nasensprays:** Nur für wenige Tage geeignet; eine längere Anwendung führt zu Gewöhnung und sogar zu einer noch stärkeren Verstopfung.

Privatpraxis Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Türkei
Tel.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

5 Was geschieht, wenn der Eingriff nicht durchgeführt wird?

Wird die Operation nicht durchgeführt, begradigt sich die Verkrümmung nicht von selbst; Beschwerden wie behinderte Nasenatmung, Mundatmung und Schnarchen bleiben bestehen und können mit zunehmendem Alter stärker werden. Dies ist in der Regel nicht lebensgefährlich; die Entscheidung für eine Operation hängt davon ab, wie stark Ihre Beschwerden Ihre Lebensqualität beeinträchtigen.

Sie haben das Recht, den empfohlenen Eingriff abzulehnen, ihn zu verschieben oder eine ärztliche Zweitmeinung einzuholen. Diese Entscheidung hat keinerlei Einfluss auf andere medizinische Leistungen, die Ihnen angeboten werden. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit vor Beginn des Eingriffs widerrufen; bitte beachten Sie jedoch, dass es nach Beginn eines Eingriffs Phasen geben kann, in denen ein Abbruch medizinisch nicht vertretbar wäre.

6 Vorbereitung auf den Eingriff

- Vor der Operation werden Blutuntersuchungen und bei Bedarf eine Computertomographie (CT) der Nasennebenhöhlen sowie weitere Untersuchungen durchgeführt, und Sie werden vom Narkosearzt untersucht.
- Sie dürfen **6–8 Stunden** vor der Operation nichts essen und nichts trinken (bitte befolgen Sie die Anweisungen des Narkosearztes).
- Wenn Sie in den Tagen vor der Operation eine Erkältung, eine Grippe oder eine fieberhafte Erkrankung bekommen, teilen Sie uns dies bitte mit; die Operation kann verschoben werden.
- Teilen Sie Ihrem Arzt **alle Medikamente** mit, die Sie einnehmen (einschließlich Blutverdünnern, Aspirin, Schmerzmitteln, Medikamenten zur Gewichtsabnahme und Hormonpräparaten), sowie alle **pflanzlichen Mittel und Nahrungsergänzungsmittel** (z. B. Omega-3, Vitamin E, Ginkgo, Knoblauch, Ginseng, Fischöl). Setzen Sie kein Medikament eigenmächtig ohne ärztlichen Rat ab.
- Informieren Sie uns unbedingt über **Allergien**, Blutungs- oder Gerinnungsstörungen, Herz- und Lungenerkrankungen, Diabetes, Bluthochdruck oder Schilddrüsenerkrankungen, frühere Operationen sowie über Probleme, die Sie bei früheren Narkosen hatten.
- Wenn Sie möglicherweise schwanger sind oder stillen, teilen Sie uns dies bitte vor dem Eingriff mit.
- Rauchen und Nikotinprodukte beeinträchtigen die Wundheilung erheblich. Hören Sie nach Möglichkeit mindestens 2–4 Wochen vor dem Eingriff damit auf und rauchen Sie während der Heilungsphase nicht.

7 Heilungsverlauf: Was Sie erwartet

Erste 48 Stunden	Wegen der Schienen fühlt sich Ihre Nase verstopft an, und Sie müssen mit leichtem blutigem Nachsickern, Kopfschmerzen und einem trockenen Hals rechnen. Die Schmerzen sind meist gering. Es wird empfohlen, mit erhöhtem Kopf zu schlafen. Der Mullverband unter der Nase muss eventuell einige Male gewechselt werden.
3.–7. Tag	Silikonschienen oder Tamponaden werden in der Regel bei einem Kontrolltermin zwischen dem **3. und 7. Tag** entfernt; dies verursacht kurzzeitig Unbehagen. Mit Nasenspülungen wird begonnen. Die meisten Menschen nehmen eine Bürotätigkeit innerhalb von 5–7 Tagen wieder auf.
2.–4. Woche	Krustenbildung und Trockenheit in der Nase können auftreten und bessern sich mit regelmäßigem Spülen. Die Atmung wird allmählich freier. Anstrengender Sport und Kontaktsportarten sollten für etwa **3–4 Wochen** zurückgestellt werden.
1.–3. Monat	Die Nasenschleimhaut heilt vollständig ab. Das endgültige Ergebnis für die Atmung wird in der Regel in diesem Zeitraum beurteilt.

8 Mögliche Risiken und Komplikationen

Wie jeder medizinische Eingriff ist auch dieser Eingriff mit gewissen Risiken verbunden. Im Folgenden sind **zu erwartende vorübergehende Begleiterscheinungen** und **Komplikationen** getrennt aufgeführt und nach ihrer Häufigkeit geordnet. Die angegebenen Zahlen sind **ungefähre** Werte aus der medizinischen Fachliteratur; Ihr

Privatpraxis Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Türkei
Tel.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

persönliches Risiko kann je nach Alter, allgemeinem Gesundheitszustand, Rauchen und früheren Operationen niedriger oder höher sein.

Die allermeisten Komplikationen sind **vorübergehend** und bessern sich bei angemessener Behandlung. Aufgeführt sind auch sehr seltene, aber schwerwiegende Ereignisse; dass sie hier stehen, bedeutet nicht, dass sie bei Ihnen auftreten werden, doch Sie sollten sie kennen, um eine informierte Entscheidung treffen zu können.

Zu erwartende, vorübergehende Begleiterscheinungen (keine Komplikationen – ein normaler Teil der Heilung)

- Verstopfte Nase und Mundatmung, bis die Schienen entfernt sind
- Leichtes blutiges Nachsickern in den ersten Tagen
- Vorübergehendes Taubheitsgefühl der oberen Frontzähne und der Oberlippe
- Krustenbildung und Trockenheit in der Nase (in den ersten Wochen)
- Vorübergehend vermindertes Riechvermögen

Häufige Beschwerden (meist vorübergehend oder mit Behandlung rückläufig)

- **Länger anhaltende Krustenbildung und Trockenheit** — Kann mehrere Wochen anhalten, besonders wenn die Nasenmuscheln verkleinert wurden; bessert sich mit Spülungen und befeuchtender Nasensalbe.
- **Länger anhaltendes Taubheitsgefühl der oberen Zähne und der Lippe** — Klingt in der Regel innerhalb weniger Wochen ab; selten kann es einige Monate anhalten.
- **Nasenatmungsbehinderung bessert sich nicht vollständig** — Bei etwa **15–30 von 100** Patientinnen und Patienten bessert sich die Atmung möglicherweise nicht so stark wie erwartet. Dies liegt oft an zusätzlichen Faktoren wie Allergie, Schleimhautschwellung oder schwachen Nasenflügeln; eine medikamentöse Behandlung oder eine weitere Operation kann notwendig sein.

Gelegentliche Beschwerden

- **Nasenbluten** — Bei etwa **1–3 von 100** Patientinnen und Patienten kann eine Blutung auftreten, die eine Tamponade erfordert. Sehr selten muss die Blutung im Operationssaal gestillt werden.
- **Loch in der Nasenscheidewand (Perforation)** — Bei etwa **1–3 von 100** Patientinnen und Patienten kann ein Loch im Septum entstehen. Oft verursacht es keine Beschwerden; führt es zu Pfeifgeräuschen, Krustenbildung oder Blutungen, können Spülungen, ein Septumknopf (Obturator) oder eine Verschlussoperation notwendig sein.
- **Verwachsungen in der Nase (Synechien)** — Bei etwa **1–5 von 100** Patientinnen und Patienten können sich Verwachsungen zwischen Septum und Seitenwand bilden; behindern sie die Atmung, werden sie bei einer Kontrolle mit einem einfachen Eingriff gelöst.
- **Blut- oder Eiteransammlung in der Nasenscheidewand (Hämatom / Abszess)** — Tritt bei **weniger als 1 von 100** Patientinnen und Patienten auf. Es äußert sich in den Tagen nach der Operation durch zunehmende Nasenatmungsbehinderung, Schmerzen und Fieber. Es muss **dringend entlastet** werden, um eine Schädigung des Nasenknorpels zu vermeiden; unbehandelt kann es zu Knorpelverlust und einem Einsinken des Nasenrückens kommen.
- **Infektion** — Selten; sie heilt in der Regel mit Antibiotika ab.
- **Erneute Verkrümmung** — Da Knorpel ein „Gedächtnis" hat, kann sich das Septum mit der Zeit wieder leicht verbiegen; verursacht dies Beschwerden, kann eine zweite Operation notwendig werden.

Seltene oder sehr seltene, aber möglicherweise schwerwiegende Komplikationen

- **Einsinken des Nasenrückens (Sattelnase)** — Tritt bei **weniger als 1 von 100** Patientinnen und Patienten auf. Eine Schwächung des stützenden Septumknorpels oder ein Knorpelverlust nach einem Hämatom/Abszess kann dazu führen, dass der Nasenrücken einsinkt; dies verändert das äußere Erscheinungsbild der Nase und erfordert zur Korrektur eine weitere Operation mit Knorpeltransplantat.

Privatpraxis Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Türkei
Tel.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- **Absinken oder Formveränderung der Nasenspitze** — Sehr selten; kann auftreten, wenn stützende Strukturen betroffen sind.
- **Dauerhaft vermindertes oder verlorenes Riechvermögen** — Sehr selten.
- **Austritt von Hirnwasser (Liquorleck) und Hirnhautentzündung (Meningitis)** — Da der obere Teil des Septums an die Schädelbasis grenzt, handelt es sich hierbei um eine äußerst seltene Komplikation, die in **weit weniger als 1 von 10.000** Fällen auftritt. Tritt sie auf, können eine Krankenhausaufnahme, eine weitere Behandlung und eine Verschlussoperation notwendig werden.
- **Empty-Nose-Syndrom (Syndrom der leeren Nase)** — Werden die Nasenmuscheln zu stark verkleinert, kann trotz offener Nase ein Gefühl von Verstopfung und Trockenheit entstehen. Dies ist sehr selten; deshalb werden die Nasenmuscheln schonend verkleinert. Tritt es auf, kann es lange anhalten oder dauerhaft sein und ist schwer zu behandeln.
- **Toxisches Schocksyndrom** — Eine sehr seltene, aber schwere Erkrankung im Zusammenhang mit Nasentamponaden/-schienen (plötzliches hohes Fieber, Hautausschlag, niedriger Blutdruck), die eine sofortige Behandlung erfordert. Sie muss im Krankenhaus, manchmal auf der Intensivstation, behandelt werden und kann lebensbedrohlich sein.
- **Sehstörung, Blutung um das Auge** — Bei einer Septumplastik äußerst selten; das Risiko ist etwas höher, wenn sie mit einer Nasennebenhöhlenoperation wie FESS kombiniert wird, und wird auf einem separaten Aufklärungsbogen erläutert.

Allgemeine Risiken jedes operativen / medizinischen Eingriffs

- **Narkoserisiken:** Wird eine Vollnarkose oder Sedierung (Dämmerschlaf) durchgeführt, erläutert Ihnen der Narkosearzt deren Risiken (Übelkeit, Halsschmerzen, Zahnschäden, allergische Reaktion und sehr selten Herz- oder Lungenprobleme) gesondert, und Ihre Einwilligung wird auf einem **separaten Narkose-Aufklärungsbogen** eingeholt.
- **Blutung und Bluttransfusion:** Eine Bluttransfusion ist bei diesen Eingriffen nur sehr selten erforderlich. Bei einer schweren Blutung können Blut oder Blutprodukte notwendig werden; diese bergen eigene, sehr seltene Risiken (z. B. Allergie oder Infektion).
- **Infektion:** Eine Wundinfektion nach der Operation wird in der Regel mit Antibiotika behandelt; selten kann eine Drainage (Ableiten des Eiters) notwendig sein.
- **Blutgerinnsel in den Beinvenen (Thrombose) und in der Lunge (Lungenembolie):** Bei kurzen Operationen im Kopf-Hals-Bereich sehr selten. Frühes Aufstehen und Gehen senkt das Risiko. Hormonpräparate, Rauchen, starkes Übergewicht und frühere Blutgerinnsel erhöhen das Risiko.
- **Medikamentenallergie:** Auf die verwendeten Medikamente, Desinfektionsmittel, Pflaster oder Nahtmaterialien kann eine allergische Reaktion auftreten.
- **Narbenbildung und Heilungsstörungen:** Wie Narben verheilen, ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich; sehr selten kann sich eine verdickte (hypertrophe) Narbe oder ein Keloid bilden.
- **Lebensgefahr:** Todesfälle bei geplanten Operationen im Kopf-Hals-Bereich sind heute äußerst selten; dennoch ist kein operativer Eingriff völlig frei von Risiken. Eine schwere Komplikation kann eine Behandlung auf der Intensivstation erforderlich machen und zu einer bleibenden Behinderung führen.

Diese Aufstellung umfasst nicht jede denkbare Komplikation; andere unvorhersehbare und sehr seltene Ereignisse können auftreten. Tritt eine Komplikation auf, plant Ihr Arzt die notwendige Behandlung und Nachsorge; dies kann eine zusätzliche Behandlung, Medikamente, Eingriffe oder eine erneute Operation erfordern.

Privatpraxis Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Türkei
Tel.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

9 Wann Sie sich sofort bei uns melden sollten

- **Nasenbluten, das nicht aufhört oder sehr stark ist**, obwohl Sie einige Minuten lang Druck ausgeübt und Eis aufgelegt haben, oder Blut, das ständig in den Mund läuft
- **Zunehmende Nasenatmungsbehinderung, starke Schmerzen und Schwellung der Nase** in den Tagen nach der Operation (kann ein Zeichen für ein Septumhämatom/einen Septumabszess sein)
- **Fieber über 38,5 °C** oder übel riechende Absonderung
- **Plötzliches hohes Fieber, Hautausschlag, Schwindel oder Schwäche**, während Tamponaden/Schienen in der Nase liegen
- **Klare, wässrige Absonderung** aus der Nase, besonders wenn sie beim Vorbeugen zunimmt; starke Kopfschmerzen oder Nackensteifigkeit
- **Verschwommenes Sehen oder Doppelbilder** oder Schwellung um das Auge
- Atemnot oder Schmerzen in der Brust

Wenn eines dieser Anzeichen auftritt, rufen Sie unverzüglich Ihren Arzt an: +90 288 502 50 20 · WhatsApp +90 555 333 21 20. Wenn Sie uns nicht erreichen, suchen Sie die nächste Notaufnahme auf oder wählen Sie die 112 (Notrufnummer in der Türkei und in ganz Europa).

10 Hinweise zu Medikamenten und zum Alltag

- Schnäuzen Sie sich in den ersten 2 Wochen nicht; halten Sie beim Niesen den Mund offen.
- Spülen Sie Ihre Nase so, wie es Ihnen gezeigt wurde, und so oft wie empfohlen.
- Vermeiden Sie in den ersten 2 Wochen heiße Bäder, Sauna, Hamam (türkisches Dampfbad) und schweres Heben.
- Schützen Sie Ihre Nase mindestens 4 Wochen lang vor Stößen.
- Wenn Sie aus dem Ausland angereist sind, ist ein Flug in der Regel unbedenklich, sobald die Schienen entfernt wurden.
- Nehmen Sie die Ihnen verordneten Medikamente (Antibiotika, Schmerzmittel usw.) in der empfohlenen Dosierung und für die empfohlene Dauer ein. Nehmen Sie Aspirin oder ähnliche Medikamente, die Blutungen verstärken können, nicht ohne Rücksprache mit Ihrem Arzt ein.
- Trinken Sie nach der Operation bei Flügen oder Reisen von mehr als 4 Stunden reichlich Wasser, bewegen Sie sich regelmäßig und tragen Sie, falls empfohlen, Kompressionsstrümpfe; dies senkt das Risiko von Blutgerinnseln in den Beinen.
- Während der Heilungsphase wird empfohlen, keinen Alkohol zu trinken und auf Rauchen und Nikotinprodukte zu verzichten.
- Bitte nehmen Sie alle Kontrolltermine wahr. Wenn Sie aus dem Ausland angereist sind, kann die Nachsorge nach Ihrer Rückkehr per Online-Sprechstunde und Fotos/Videos fortgeführt werden; falls Sie einen Arzt vor Ort aufsuchen müssen, erhalten Sie einen schriftlichen Operationsbericht und unsere Empfehlungen.

11 Unerwartete Befunde während des Eingriffs, Gewebeproben und Blutprodukte

Ergibt sich während des Eingriffs eine unvorhergesehene Situation, hält sich Ihr Arzt an den Umfang des Eingriffs, in den Sie mit diesem Bogen eingewilligt haben. **Sofern keine Lebensgefahr und keine Gefahr eines schweren Organschadens besteht**, wird kein zusätzlicher Eingriff vorgenommen, in den Sie nicht eingewilligt haben; in diesem Fall wird der Eingriff an einem sicheren Punkt beendet, und Sie werden anschließend informiert, damit die Entscheidung gemeinsam mit Ihnen getroffen werden kann. Besteht Lebensgefahr, wird die Notfallbehandlung durchgeführt, die zum Schutz Ihres Lebens oder des Organs erforderlich ist.

Während des Eingriffs entnommenes Gewebe wird, wenn nötig, zur Sicherung der Diagnose zur **feingeweblichen (pathologischen) Untersuchung** eingesandt. Je nach Ergebnis kann eine weitere Behandlung oder Nachsorge erforderlich sein.

Privatpraxis Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Türkei
Tel.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

Eine Bluttransfusion ist bei diesen Eingriffen nur sehr selten notwendig und wird nur verabreicht, wenn sie lebenswichtig ist. Wenn Sie Blut oder Blutprodukte ablehnen (zum Beispiel aus religiösen Gründen), müssen Sie uns dies vor dem Eingriff mitteilen; die möglichen Folgen dieser Entscheidung werden gesondert mit Ihnen besprochen und unter „Informationen speziell für Sie“ festgehalten.

12 Fotos, Bildaufnahmen und Ihre personenbezogenen Daten

Vor und nach dem Eingriff können zur Planung, Verlaufskontrolle und Beurteilung des Ergebnisses **Fotos/Videos** angefertigt werden. Diese Aufnahmen sind Teil Ihrer Krankenakte und werden vertraulich behandelt. Ihre Aufnahmen werden **niemals für Werbung, Öffentlichkeitsarbeit oder soziale Medien verwendet.**

Für jeden anderen Zweck dürfen Ihre Aufnahmen **nur mit Ihrer gesonderten und ausdrücklichen Erlaubnis** verwendet werden. Eine Ablehnung hat keinerlei Einfluss auf Ihre Behandlung, und Sie können Ihre Erlaubnis jederzeit widerrufen:

☐ Ich bin damit einverstanden, dass meine Aufnahmen **ausschließlich für die medizinische Dokumentation und die Verlaufskontrolle der Behandlung** verwendet werden.

☐ Ich erlaube die Verwendung meiner Aufnahmen für wissenschaftliche Veröffentlichungen und die ärztliche Aus- und Weiterbildung **in einer Form, in der ich nicht erkennbar bin** (Gesicht/Augenpartie abgedeckt).

☐ Ich erlaube die Verwendung meiner Aufnahmen für wissenschaftliche Veröffentlichungen und die ärztliche Aus- und Weiterbildung **in einer Form, in der ich erkennbar sein kann**.

☐ Ich **erlaube keine** Verwendung zu wissenschaftlichen Zwecken / Ausbildungszwecken.

Ihre personenbezogenen Daten und Gesundheitsdaten werden nach dem türkischen Gesetz Nr. 6698 zum Schutz personenbezogener Daten (KVKK) und den einschlägigen gesundheitsrechtlichen Vorschriften zu Zwecken der Diagnose, der Behandlung und der Erfüllung gesetzlicher Pflichten von Personen verarbeitet, die der beruflichen Schweigepflicht unterliegen. Einzelheiten entnehmen Sie bitte unseren Datenschutzhinweisen.

13 Informationen und Anmerkungen speziell für Sie (vom Arzt auszufüllen)

Patientenspezifische zusätzliche Risiken (Begleiterkrankungen, Medikamente, frühere Operationen), Einzelheiten der Planung, Erwartungen der Patientin / des Patienten, gestellte Fragen und gegebene Antworten. Gibt es nichts zu ergänzen, „keine“ eintragen.

14 Erklärung der Patientin / des Patienten

☐ Ich habe diesen Bogen in meiner Sprache gelesen und verstanden. Ich hatte ausreichend Bedenkzeit, konnte Fragen stellen und habe zufriedenstellende Antworten erhalten.

☐ Meine Erkrankung, das Ziel des empfohlenen Eingriffs, wie, von wem und wo er durchgeführt wird, seine voraussichtliche Dauer, der erwartete Nutzen, die Erfolgsaussichten, die Alternativen und die möglichen Folgen, wenn er nicht durchgeführt wird, wurden mir mündlich und schriftlich erklärt.

☐ Die häufigen und die möglicherweise schwerwiegenden Risiken sowie die möglichen Folgen dieser Komplikationen (einschließlich der Möglichkeit, dass eine weitere Behandlung oder ein erneuter Eingriff bzw. eine erneute Operation notwendig wird) wurden mir erklärt. Mir ist bewusst, dass das Ergebnis eines medizinischen Eingriffs **nicht zu 100 % garantiert werden kann**.

☐ Ich habe zutreffende und vollständige Angaben zu meinem Gesundheitszustand, meinen Medikamenten, meinen Allergien und früheren Erkrankungen gemacht. Mir ist bewusst, dass unvollständige oder falsche Angaben die Risiken erhöhen können.

Privatpraxis Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Türkei
Tel.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- ☐ Mir ist bewusst, dass die Befolgung der Anweisungen vor und nach dem Eingriff zum Ergebnis beiträgt und dass die Wahrnehmung der Kontrolltermine wichtig ist.
- ☐ Ich weiß, dass ich meine Einwilligung jederzeit vor Beginn des Eingriffs widerrufen kann. Mir ist bewusst, dass meine Unterschrift unter diesen Bogen den Arzt nicht von seiner Sorgfaltspflicht entbindet.
- ☐ Ich treffe diese Entscheidung aus freiem Willen und ohne Druck von irgendeiner Seite.
- ☐ Mir ist bewusst, dass das Ziel dieser Operation die Verbesserung der Atmung ist und nicht die Veränderung des äußeren Erscheinungsbildes der Nase, und dass eine weitere Behandlung notwendig sein kann, wenn die Atmungsbehinderung andere Ursachen hat.

- ☐ **Ich ERTEILE MEINE EINWILLIGUNG zu dem oben beschriebenen Eingriff.**
- ☐ **Den oben beschriebenen Eingriff LEHNE ICH AB. Die möglichen Folgen der Ablehnung wurden mir erklärt.**

Wir empfehlen, dass die Patientin / der Patient handschriftlich ergänzt: „Ich habe diesen Bogen gelesen und verstanden und willige ein.“

15 Unterschriften

	VOR- UND NACHNAME	UNTERSCHRIFT	DATUM / UHRZEIT
Patient/in			
Gesetzliche/r Vertreter/in (Elternteil / Vormund) – Verhältnis zum Patienten:			
Aufklärender und durchführender Arzt			
Dolmetscher/in (falls erforderlich) – Sprache:			
Zeuge/Zeugin (falls erforderlich)			

Erklärung der Dolmetscherin / des Dolmetschers: Ich habe diesen Bogen und die mündlichen Erläuterungen des Arztes der Patientin / dem Patienten bzw. der gesetzlichen Vertretung vollständig und korrekt in eine für sie verständliche Sprache übersetzt.

FÜR PATIENTINNEN UND PATIENTEN UNTER 18 JAHREN ODER MIT EINGESCHRÄNKTER EINWILLIGUNGSFÄHIGKEIT

Bei Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren wird die Einwilligung von einem **Elternteil oder dem gesetzlichen Vormund** erteilt. Das Kind wird seinem Alter und seiner Reife entsprechend aufgeklärt, und seine Meinung wird eingeholt. Bei nicht einwilligungsfähigen Patientinnen und Patienten erteilt die gesetzliche Vertretung die Einwilligung.

- ☐ Sofern wir das Sorgerecht gemeinsam ausüben, erkläre ich, dass der andere Elternteil über diesen Eingriff informiert ist und ihm zustimmt.
- ☐ Ich erkläre, dass keine gerichtliche Entscheidung und kein Streit über das Sorgerecht / die Vormundschaft besteht (falls doch, wurde dem Arzt das entsprechende Dokument vorgelegt).

Das Kind wurde altersgerecht aufgeklärt; Meinung des Kindes: _____

Privatpraxis Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Türkei
Tel.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

Dieser Bogen wurde in zwei Exemplaren ausgefertigt: Ein Exemplar verbleibt in der Patientenakte, eines erhält die Patientin / der Patient bzw. die gesetzliche Vertretung.

WIDERRUF DER EINWILLIGUNG (NUR AUSFÜLLEN, WENN SIE SICH ANDERS ENTSCHEIDEN)

Ich widerrufe die oben erteilte Einwilligung. Die möglichen Folgen des Widerrufs wurden mir erklärt.

Name, Unterschrift, Datum und Uhrzeit der widerrufenden Person (Patient/in bzw. Vertreter/in): _____

Dieser Bogen wurde in Übereinstimmung mit der türkischen Patientenrechteverordnung und den Grundsätzen der Türkischen Ärztekammer zur Aufklärung und Einwilligung erstellt. Er ergänzt das mündliche Aufklärungsgespräch mit Ihrem Arzt, ersetzt es aber nicht.